

EVEKTIFITAS TERAPI AKUPRESURE PADA TITIK SP6 DAN LI4 TERHADAP DISMENORE PADA REMAJA PUTRI

Marchatus Soleha
Vika Tri Zelharsandy



EVEKTIFITAS TERAPI *AKUPRESURE* PADA TITIK SP6 DAN LI4 TERHADAP *DISMENORE* PADA REMAJA PUTRI

Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.

Vika Tri Zelharsandy, M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Evektifitas Terapi *Akupresure* Pada Titik Sp6 Dan Li4 Terhadap *Dismenore* Pada Remaja Putri

Penulis: Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.
Vika Tri Zelharsandy, M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-08-5

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Evektifitas terapi akupresure pada titik SP6 dan LI4 terhadap dismenore pada remaja putri / penulis, Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes., Vika Tri Zelharsandy, M.Keb.
EDISI	Cetakan pertama, Februari 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	vi, 73 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-08-5
SUBJEK	Akupresur -- Dismenore
KLASIFIKASI	615.892 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1187860

PRAKATA

Bissmillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku tentang " **Evektifitas Terapi Akupresure Pada Titik Sp6 Dan Li4 Terhadap Dismenore Pada Remaja Putri**". Buku ini digunakan untuk memberikan informasi tentang pijat Pada Titik Sp6 Dan Li4 Terhadap Dismenore Pada Remaja Putri. Dalam penyusunan buku ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini maka penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk yang membaca dan masyarakat.

Palembang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
--------------	-----

DAFTAR ISI.....	iv
-----------------	----

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 REMAJA PUTRI.....	7
--------------------------------	----------

A. Remaja	7
B. Perubahan Sekunder dan Primer Pada Remaja Putri Pada Masa Pubertas.....	10

BAB 3 MENSTRUASI PADA REMAJA	15
---	-----------

A. Pengertian Menstruasi.....	15
B. Siklus Menstruasi	17
C. Gangguan Siklus Menstruasi.....	20
D. Penyebab Polimenorea.....	21
E. Penyebab Hipomenorea	26
F. Hormon Pengendali Proses Menstruasi.....	27
G. Pre Menstruation Syndrom (PMS).....	29

BAB 4 DISMENOREA	31
-------------------------------	-----------

A. Pengertian Dismenore	31
B. Etiologi Dismenore	32
C. Klasifikasi Dismenore.....	33
D. Faktor penyebab Dismenore Primer.....	38
E. Derajat Dismenore	39
F. Derajat Pengukuran Nyeri (Numeric Rating Scale)....	40

BAB 5 TERAPI NON KONVESIONAL	43
A. Pengertian Terapi Non Konvensional	43
B. Pengertian Terapi Akupresure	44
C. Manfaat Akupresure	46
D. Cara Melakukan <i>Akupresure</i>	47
 BAB 6 AKUPRESURE UNTUK DISMENORE	48
A. Pengaruh Pemijatan <i>Akupresure</i> Pada Dismenore	48
B. Titik akupresure untuk mengatasi dismenore	49
 BAB 7 PENUTUP.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	55
 GLOSARIUM	62
 PROFIL PENULIS	65

BAB 1

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari pubertas ke dewasa, yaitu pada umur 11-20 tahun. Pada masa peralihan tersebut individu matang secara fisiologis, mental, emosional dan sosial. Berbagai masalah yang timbul pada menstruasi merupakan masalah ginekologi yang sering dikeluhkan oleh remaja, seperti ketidakteraturan menstruasi, *menoraghia*, *dismenorea*, dan gejala lain yang berhubungan (Widayati et al, 2020).

Masa remaja yakni peralihan periode bocah menuju dewasa dimana ditunjukkan oleh perubahan psikis, emosi, serta fisik. Masa tersebut terjadi melewati tiga tahap, dimana tiap tahapnya ditunjukkan oleh transformasi biologis, sosial, serta psikologis, meliputi pada usia 12-15 tahun (remaja awal), 15-18 tahun (remaja menengah), serta 19-22 tahun (remaja akhir) (Sari Priyanti, 2014).

Menstruasi yakni peristiwa natural dimana timbul terhadap perempuan normal. Kondisi tersebut timbul dikarenakan lapisan endometrium uterus yang terlepas. (Wijayanti dan Selviana, 2019).

Dismenorea tersusun dari kata *dys*, *meno* dan *rhea*. "*Dys*" yang berarti nyeri, abnormal, "*meno*" berarti bulan dan "*rhea*" berarti arus. Sehingga *dismenorea* sebagai aliran menstruasi yang sulit (*difficult menstrual flow*). *Dismenorea* sering disebut dengan "painful period" atau menstruasi yang menyakitkan (Issabella et al., 2022).

Dismenorea merupakan masalah ginekologi yang biasanya timbul pada masa remaja yaitu sekitar 2 – 3 tahun setelah menarche yang ditandai dengan kram perut atau nyeri perut bagian bawah yang berlangsung selama 8 – 72 jam pada hari pertama atau kedua menstruasi (Issabella et al., 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan *dismenore* primer yaitu adanya peningkatan hormon *prostaglandin* yang bisa meningkatkan kontraksi *myometrium* dan mampu mempersempit pembuluh darah, sehingga terjadi kontraksi otot-otot rahim. Remaja putri biasanya akan mengalami *dismenore* primer dalam periode haidnya (Desreza and marwati, 2020).

Dismenorhea berdampak buruk pada kehidupan remaja, *dismenorhea* dapat mengakibatkan aktivitas terganggu, prestasi akademik lebih rendah, mengganggu kinerja dan kualitas tidur, berdampak negatif pada suasana hati, serta menyebabkan kegelisahan dan depresi. Selain itu remaja putri yang mengalami *dismenorhea* akan merasa terbatas dalam melakukan aktivitas khususnya aktivitas belajar di sekolah (Hasna et al, 2021).

Beberapa dampak lain dari dysmenorrhea primer maupun sekunde diantaranya adalah terganggunya aktivitas sehari-hari. Dampak dysmenorrheayang paling fatal bila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kemandulan (infertilitas) dan gangguan seksual pada kejadian dysmenorrhea primer (Tanna, 2016; Handayani dkk, 2016; Sari dkk, 2018; Ammar, 2016; Soderman dkk, 2018; Osonuga, 2018; dan Ishikura, 2020).

Penyebab dysmenorrhea dikarenakan oleh endometriosis (radang panggul), kelainan uterus, tumor, kelainan vagina ataupun selaput dara yang tidak mempunyai lubang, cemas serta stres yang melampaui batas.

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2020, kejadian *dysmenorrhea* adalah 1.769.425 (90%) remaja wanita yang menderita *dysmenorrhea*, dengan 10-16% menderita *dysmenorrhea* berat. Angka kejadian *dysmenorrhea* di dunia sangat tinggi. Besar rata-rata lebih dari 50% remaja wanita menderita karenanya (Herawati, 2021). Data *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 2020, *presentase dysmenorrhea* di negara Singapura sekitar 10-15%, negara Malaysia 35-40% dan Thailand 65% (ASEAN, 2020).

Penanganan nyeri haid (*dysmenore*) bisa dilakukan dengan terapi farmakologi maupun non farmakologi. Upaya farmakologi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan obat analgetik yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit berupa obat anti *prostaglandin* atau obat anti inflamasi. Selain itu, terdapat obat devira asam propionat (naproksen, ibuprofen, ketoprofen), fenamat (asam mefenamat, asam tolafenamat, asam flufenamat, muklofenamat). Selain itu, terapi non farmakologi dapat dilakukan sebagai upaya menangani tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Penanganan nyeri secara non farmakologi yaitu kompres hangat, menggosok pinggang dan perut, yoga dan aromaterapi, dan salah satunya yaitu dengan melakukan terapi pijat *akupresure* (Realita et al, 2021).

Akupresure merupakan teknik pengobatan tradisional dari Tiongkok. Teknik ini mirip dengan akupunktur, tetapi tidak menggunakan jarum. *Akupresure* diduga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sistem saraf, serta membuat tubuh menjadi rileks (Rahayu, 2022).

Salah satu *akupresure* yang dipergunakan pada penanganan *dysmenorrhea* adalah *akupresure* di titik SP6 (*sanyinjiao*). Titik SP6 yakni titik yang dipergunakan dalam

menguatkan limpa, memulihkan keseimbangan Yin serta Yang, ginjal, hati, dan darah serta melancarkan suplai darah juga peredarannya. *Akupresure* sanyinjiao point tersebut memiliki keunikan, yakni lokasi bertemunya tiga meridian Yin di kaki. Adapun riset dengan judul "*Effects of SP6 acupressure on pain and menstrual distress in young women with dysmenorrhea*" dalam Efriyanti dkk (2020) menjabarkan oleh penyembuhan Tionghoa, rahim termasuk organ terkait ke ginjal serta jantung melewati jalur tertentu, juga suplai darah di hati disalurkan ke rahim. Bila penyalurannya darah hanya sedikit menuju hati. artinya penyalurannya juga sedikit menuju rahim. Kondisi tersebutlah yang mengakibatkan teradinya *dysmenorrhea*. Terapi *akupresure sanyinjiao point* bisa menolong melancarkan suplai darah juga peredarannya antara tiga bulanan (Rahmawati dkk, 2022).

Selain itu teknik *akupresure* yang digunakan oleh penulis ialah *akupresure* titik hegu (LI4). Teknik *akupresure* pada daerah tangan (terletak di *antara os metacarpal I dan II dari os II metacarpal radial* tengah atau di permukaan punggung tangan antara ibu jari dan jari telunjuk kira-kira di tengah tulang metacarpal kedua). Terbukti dalam penelitian El-Gendy bahwa *akupresure* menurunkan intensitas nyeri dan kualitas nyeri saat menstruasi, mengurangi lokasi nyeri *dysmenore* serta mengurangi gejala yang menyertai *dysmenore* pada remaja putri (Hasanah, Lestari, Novayelinda, & Deli, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, terapi *akupresure* untuk menurunkan *dysmenorrhea* berpengaruh untuk menurunkan nyeri *dysmenorrhea*. Karena terapi *akupresure* memiliki efek yang dihasilkan melalui penekanan pada titik tertentu sehingga merangsang dan cepat menurunkan nyeri. Selain itu, tindakan *akupresure* ini mudah dilakukan di rumah, murah, dan tentunya

dapat mengurangi efek samping dari penggunaan obat (Mulya, 2022).

Peran bidan salah satunya untuk masalah gangguan reproduksi terutama pada *dismenorea* primer dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan reproduksi bidan merupakan fasilitator dalam mempromosikan kesehatan misalnya adanya penyuluhan mengenai menstruasi pada remaja dan nyeri yang timbul saat menstruasi atau disebut juga *dismenore*. Bidan memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, penanganan dan promosi kesehatan dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkan pertolongan kapanpun dan dimanapun dia berada (Gustina & Safitri, 2022).

Akupresur yang dikenal dengan tusuk jari ataupun totok termasuk wujud fisioterapi melalui pemberian stimulasi serta pijatan di sejumlah titik tubuh. Akupresur mempunyai manfaat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit, rehabilitasi ataupun pemulihan, serta mampu mendongkrak daya tahan

tubuh (Rahayu, 2018). Contoh akupresur yang dipergunakan pada penanganan dysmenorrhea adalah akupresur di titik SP6 (sanyinjiao). Titik SP6 yakni titik yang dipergunakan dalam menguatkan limpa, memulihkan keseimbangan Yin serta Yang, ginjal, hati, dan darah serta melancarkan suplai darah juga peredarannya. Akupresur sanyinjiao point tersebut memiliki keunikan, yakni lokasi bertemunya tiga meridian Yin kaki.

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi pemanfaatan terapi

akupresure pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri Secara spesifik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 memiliki manfaat untuk menurunkan tingkat nyeri *dismenore* primer secara non farmakologi.

Terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri efektif. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan ilmu kebidanan terapi non konvensional terkait dengan upaya menurunkan tingkat nyeri *dismenore* primer secara non farmakologi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi suatu alternatif bagi bidan khususnya untuk menurunkan tingkat nyeri *dimenore* primer secara non farmakologi. Serta sebagai bahan riset selanjutnya mengenai efektifitas terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri. Buku monograf ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan pertimbangan tenaga kesehatan supaya lebih menambah kepedulian kepada para remaja terkait kesehatan reproduksi serta *dismenore*, dan cara mengatasinya.

Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan alternatif bagi bidan khususnya untuk menurunkan tingkat nyeri *dimenore* primer secara non farmakologi. Serta sebagai bahan riset selanjutnya mengenai efektifitas terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri.

BAB 2

REMAJA PUTRI

A. Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini sering disebut dengan masa pubertas. Masa remaja juga merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Masa remaja sering digambarkan sebagai masa yang paling indah dan tidak terlupakan karena penuh dengan kegembiraan dan tantangan (Teori Kesehatan Reproduksi, 2019).

Remaja artinya manusia berusia belasan tahun. Di mana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak, tetapi belum juga berada dalam golongan dewasa tua. Masa remaja (usia 10 sampai dengan 19 tahun) dikenal dengan masa storm dan stress. Masa tersebut terjadi pergolakan emosi yang diringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan secara psikis. Masa remaja terdiri dari masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja tengah (15-18 tahun) dan masa remaja akhir (18-21 tahun) (Harahap, 2019). Sedangkan menurut WHO, yang dikatakan usia remaja adalah antara 10-19 tahun (Setyawan, 2018).

1. Tahap- Tahap Masa Remaja

Masa remaja berlangsung dalam 3 tahapan yang masing-masing ditandai dengan isu-isu biologik, psikologik dan sosial, yaitu (Harahap, 2019):

a. Masa Remaja Awal (12-15 Tahun)

Masa remaja awal (12-15 tahun) ditandai dengan peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik. Jadi, tidaklah mengherankan apabila sebagian besar dari energi intelektual dan emosional pada masa remaja awal ini ditargetkan pada penilaian kembali dan restrukturisasi dari jati dirinya.

b. Masa Remaja Menengah (15-18 Tahun)

Masa remaja menengah (15-18 tahun) ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir baru, peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa dan keinginan untuk memapankan arak emosional dan psikologis dengan orang tua.

c. Masa Remaja Akhir (18-21 tahun)

Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan untuk peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi dari tujuan pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi. Diketahui bahwa seorang wanita mengalami menstruasi yang teratur setelah memasuki usia 18 tahun, karena organ reproduksi mulai mempersiapkan kematangan

2. Ciri Perkembangan Remaja Putri

Ciri-ciri perkembangan remaja putri menurut Hurlock (2021), antara lain:

Perubahan Tubuh Pada Masa Pubertas

a. Perubahan Ukuran Tubuh

Perubahan fisik utama pada masa puber adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan. Di antara anak-anak perempuan, rata-rata peningkatan per tahun dalam tahun sebelum haid adalah 3 inci, tetapi peningkatan itu bisa juga terjadi dari 5 sampai 6 inci. Dua tahun sebelum haid peningkatan rata-rata adalah 2,5 inci. Jadi peningkatan keseluruhan selama dua tahun sebelum haid adalah 5,5 inci. Setelah haid, tingkat pertumbuhan menurun sampai kira-kira 1 inci setahun dan berhenti sekitar delapan belas tahun. Tinggi badan rata-rata laki-laki dan perempuan umur 12 tahun adalah sekitar 59 atau 60 inci, sedangkan tinggi rata-rata remaja perempuan hanya 64 inci. Penambahan berat badan dalam 1 tahun yakni rata-rata sekitar 13kg bagi anak laki-laki dan 10 kg bagi Perempuan (Hurlock, 2021).

b. Perubahan Proporsi Tubuh

Perubahan fisik pokok yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. Daerah-daerah tubuh tertentu yang tadinya terlampau kecil, sekarang menjadi terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Badan yang kurus dan panjang mulai melebar di bagian pinggul dan bahu, dan ukuran pinggang tampak tinggi karena kaki menjadi lebih panjang dari badan (Hurlock, 2021).

c. Akibat Perubahan Remaja Putri Pada Masa Puber

Akibat terhadap keadaan fisik

Pertumbuhan yang pesat dan perubahan-perubahan tubuh cenderung disertai kelelahan, kelesuan dan gejala-gejala buruk lainnya. Sering terjadi gangguan pencernaan dan nafsu makan kurang baik. Anak prapuber sering terganggu oleh perubahan-perubahan

kelenjar, besarnya, dan posisi organ-organ internal. Perubahan-perubahan ini mengganggu fungsi pencernaan yang normal. Anemia sering terjadi pada masa ini, bukan karena adanya perubahan dalam kimiawi darah tetapi kebiasaan makan yang tidak menentu yang semakin menambah kelelahan dan kelesuan (Hurlock, 2021).

Akibat pada sikap dan perilaku

Dapat dimengerti bahwa akibat yang luas dari masa puber pada keadaan fisik anak juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Pada umumnya pengaruh masa puber lebih banyak pada anak perempuan dari pada anak laki-laki, sebagian disebabkan karena anak perempuan biasanya lebih cepat matang daripada anak laki-laki dan sebagian karena banyak hambatan-hambatan sosial mulai ditekankan pada perilaku anak perempuan justru pada saat anak perempuan mencoba untuk membebaskan diri dari berbagai pembatasan (Hurlock, 2021).

B. Perubahan Sekunder dan Primer Pada Remaja Putri Pada Masa Pubertas

Remaja sebelum mengalami pubertas akan mengalami beberapa tahap, menurut Migwar (2019) yang dinamakan prapubertas yang dimulai dari umur 9-10 tahun. Pada tahap ini tidak disebut sebagai anak dan tidak pula disebut sebagai seorang remaja. Ciri-ciri sekunder mulai tampak pada tahap ini, namun belum berkembang secara sempurna.

Tanner membuat klasifikasi tingkat kematangan seksual (TKS) remaja dalam 5 stadium (Soetjiningsih, 2010 dalam Rahayu et al., 2019):

Tabel 2.1. Tingkat Kematangan Seksual pada Perempuan

Stadium TKS	Rambut Pubis	Payudara
1	Pra pubertas	Pra pubertas
2	Jarang, pigmen sedikit, lurus, sekitar labia	Payudara dan papilla menonjol. Diameter areola bertambah
3	Lebih hitam, mulai ikal, jumlah bertambah	Payudara dan areola sudah muncul batas tidak jelas.
4	Keriting, kasar, lebat, lebih sedikit dari dewasa.	Areola dan papilla membentuk bukit kedua.
5	Bentuk segitiga dan menyebar pada bagian paha	Bentuk dewasa, papilla menonjol, areola merupakan bagian dari bentuk payudara.

Sumber: (Rahayu, Widiarti & Yulviana, 2022)

1. Perubahan Primer

Perubahan primer pada perempuan ditandai dengan menstruasi yang menandakan ovarium telah dapat menghasilkan sel telur. Proses menstruasi terjadi saat sel telur yang dihasilkan ovarium sudah matang dan memasuki rahim. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka dalam beberapa hari sel telur akan mati.

Sel telur yang mati tersebut akan luruh bersama penebalan yang terjadi pada dinding rahim dan dikeluarkan melalui vagina. Jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan berkembang dan tumbuh menjadi janin.

Menstruasi pertama biasanya dialami oleh anak perempuan pada usia 10 sampai 14 tahun. Menstruasi umumnya berlangsung selama 3 sampai 7 hari, dan terjadi satu kali setiap 28-31 hari. Namun perlu dipahami bahwa periode tersebut tidak sama pada setiap perempuan. Pada awalnya, menstruasi bisa tidak teratur. Meski begitu, semakin lama menstruasi akan datang lebih teratur.

Adapun perubahan primer pada remaja wanita adalah mengalami menstruasi. Wanita yang sehat dan tidak hamil akan rutin mengalami haid setiap bulannya. remaja wanita ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium dengan cepat.

2. Perubahan Sekunder

Perubahan sekunder pada pubertas perempuan adalah perubahan pada fisik yang tampak dari luar. Terdapat sejumlah bagian tubuh perempuan yang mengalami perubahan, berikut di antaranya:

- a. Payudara: Payudara mulai terbentuk pada usia 10 tahun dan secara ukuran akan bertambah seiring bertambah dewasa.
- b. Menstruasi dan fertilitas: Menstruasi akan terjadi sekali dalam sebulan.
- c. Bentuk tubuh: Pinggul membesar, tubuh mulai berbentuk, dan sebagian besar tubuh perempuan akan menjadi gemuk.
- d. Bau badan dan jerawat: Munculnya bau badan dan jerawat karena hormon.
- e. Kulit: Kulit umumnya akan lebih berminyak.
- f. Rambut halus: Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan kemaluan.

3. Perubahan Psikologi Remaja

Perempuan daripada anak laki-laki, sebagian disebabkan karena anak perempuan biasanya lebih cepat matang daripada anak laki-laki dan sebagian karena banyak hambatan-hambatan sosial mulai ditekankan pada perilaku anak perempuan justru pada saat anak perempuan mencoba untuk membebaskan diri dari berbagai pembatasan. Karena mencapai masa puber lebih

dulu, anak Perempuan lebih cepat menunjukkan tanda-tanda perilaku yang mengganggu dari pada anak laki-laki. Tetapi perilaku anak perempuan lebih cepat stabil dari pada anak laki-laki, dan anak perempuan mulai berperilaku seperti sebelum masa puber.

Apabila dilihat dari fase perkembangan remaja, usia 10 hingga 13 tahun merupakan fase *early* karena ia baru memasuki tahapan masa puber. Maka dari itu, orangtua juga perlu mempersiapkan diri karena ia akan mengalami perubahan suasana hati serta perilaku yang berbeda dari biasanya. Beberapa perkembangan psikologi pada remaja di usia 10 hingga 13 tahun di antaranya adalah:

- a. Masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orangtua.
- b. Membuat kelompok bersama teman-teman terdekat.
- c. Mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian.

Pada saat anak berusia 10 tahun, perkembangan psikologi atau emosi remaja masih akan menunjukkan ketergantungannya pada orangtua. Namun, kedekatannya dengan teman-teman sebaya akan semakin menguat.

Bahkan, tekanan dari lingkungan pertemanan yang dirasakannya akan semakin besar. Begitu pula dengan identitas dirinya dalam sebuah pertemanan. Meski begitu, pada usia ini anak masih akan menganggap orang dewasa memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar. Hal ini membuatnya masih akan mengikuti aturan dan prinsip yang ada di dalam rumah.

Di saat yang bersamaan, pada perkembangan psikologi atau emosi remaja usia 11 hingga 13 tahun, ia mulai peduli dengan penampilan serta tubuhnya. Hal ini

biasanya terjadi karena perubahan alami yang dialami oleh tubuhnya.

Namun apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, ada kemungkinan ia mengalami masalah tertentu. Jika ia tidak suka dengan tubuhnya, misalnya ia merasa tubuhnya terlalu gemuk, ia bisa saja melakukan diet sembarangan sehingga bisa berujung pada gangguan makan serta minder.

Pada perkembangan emosi remaja di fase ini, anak juga semakin menekankan identitas dirinya. Ini bisa dilihat melalui pakaian yang digunakan, musik yang didengarkan, film yang ditonton, atau buku yang dibaca. Apabila dilakukan tanpa pengawasan, anak mungkin mulai berani mencontoh apa yang dilihatnya berdasarkan rasa penasaran. Berada di usia 12 hingga 13 tahun, Anda juga bisa melihat perkembangan psikologi atau emosi remaja yang cukup signifikan. Ini terlihat dari perubahan mood yang semakin menjadi-jadi. Satu waktu merasa bisa menaklukkan segalanya, di waktu lain anak merasa telah mengacaukan semuanya.

BAB 3

MENSTRUASI PADA REMAJA

A. Pengertian Menstruasi

Menstruasi merupakan perdarahan dari uterus yang terjadi secara periodik dan siklik, hal ini disebabkan oleh pelepasan atau deskuamasi endometrium akibat hormon *ovarium* yaitu hormon *estrogen* dan *progesteron* yang mengalami penurunan terutama *progesteron* pada akhir siklus *ovarium* yang dimulai biasanya 14 hari setelah ovulasi (Novita, 2018). Menstruasi adalah salah satu aspek kematangan seksual yang pertama kali terjadi pada masa pubertas seorang wanita. Periode menstruasi penting dalam reproduksi. Menstruasi yang terjadi secara reguler setiap bulan akan membentuk suatu siklus menstruasi (Tombakan et al., 2018).

Menstruasi ialah bagian dari proses reguler yang mempersiapkan tubuh wanita setiap bulannya untuk kehamilan. Menstruasi atau haid mengacu kepada pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Menstruasi dimulai saat pubertas antara umur 10 dan 16 tahun tergantung pada berbagai faktor (Hatmanti, 2018).

Setiap wanita mengalami pengalaman menstruasi yang berbeda-beda, sebagian wanita yang menstruasi tanpa keluhan, namun ada pula yang mengalami keluhan seperti mual muntah,

dismenore, lemah dan lesu yang dapat menghambat aktivitas. Dismenore menggambarkan keluhan nyeri atau

kram perut yang menyakitkan menyebabkan ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas fisik.

Menarche adalah perdarahan pertama kali pada remaja putri sekitar usia 12-14 tahun dan menandakan kematangan organ seksual dalam tubuh remaja putri. Pada saat menarche remaja putri mengalami perubahan fisik seperti pembesaran payudara, tumbuhnya rambut pada ketiak, pembesaran panggul dan berkembangnya organ vital yang sudah siap untuk dibuahi (Manuaba, 2019). Menarche dini merupakan menstruasi pertama kali yang terjadi pada wanita dibawah usia 12 tahun (Rosenthal, 2019). Sedangkan penelitian Susanti (2019), dikatakan bahwa usia menarche bervariasi pada setiap individu dan wilayah tempat tinggal. Namun usia menarche dapat dikatakan normal apabila terjadi pada usia 12-14 tahun.

Menurut World Health Organization (WHO) setengah dari penduduk dunia terdiri dari remaja berusia 10-19 tahun. Di Amerika Serikat tahun 2020, sekitar 95% remaja putri mempunyai tanda-tanda masa akil balig dengan menarche pada usia 12 tahun dengan usia rata-rata 12,5 tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, presentase perempuan usia 10-59 tahun menurut umur menunjukkan pada usia 9 tahun (0,3%), 10 tahun (1,2%), 11 tahun (3,7%), 12 tahun (17,2 %), 13 tahun (20,0%), 14 tahun (17,5), 15 tahun (15,2), 16 tahun (4,6), 17 tahun (3,0%), 18 tahun (1,0%), 19 tahun (0,2 %), 20 tahun (0,3) hasil menunjukkan rata-rata usia menarche di Indonesia adalah 13 tahun (20,0%) dengan kejadian lebih awal pada usia kurang dari 9 tahun dan tertua 20 tahun.

B. Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi adalah pola yang menggambarkan jarak antara hari pertama menstruasi dengan hari pertama menstruasi berikutnya (Yudita et al., 2019). Siklus menstruasi merupakan serangkaian proses menstruasi yang terdiri dari siklus hari pertama menstruasi sampai datangnya menstruasi periode berikutnya (Utami & Mardiyarningsih, 2019). Siklus menstruasi yang terganggu mengacu pada siklus menstruasi yang tertunda selama lebih dari 7 hari, atau bahkan 40-50 hari untuk setiap menstruasi.

Panjang siklus menstruasi ialah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya. Pada masing-masing Wanita mempunyai variasi dalam siklus menstruasinya ada yang masih dalam batas normal. Buku Manajemen Kesehatan Menstruasi (Sianaga, 2020) menjelaskan lamanya waktu tahapan-tahapan siklus menstruasi berdeda-beda untuk setiap wanita tapi umumnya pada siklus dengan rata-rata 28 hari terjadi tahapan seperti :

1. Hari ke-1-5 yaitu perdarahan menstruasi (masa menstruasi)
2. Hari ke-7 yaitu sel telur dalam *ovarium* sudah cukup matang
3. Hari ke-7-11 yaitu saat dinding rahim mulai menebal, sebagai persiapan untuk sel telur yang telah dibuahi (oleh sperma) agar dapat tertanam di dalam jaringan spons (spongy tissue)
4. Hari ke-14 sel telur terlepas dari *ovarium* menuju kedalam tuba fallopi, proses ini dikenal dengan nama ovulasi.
5. Hari ke-14-28 sel telur bergerak kebawah menuju rahim. Jika sel telur tersebut dibuahi, maka sel tersebut akan tertanam dalam dinding Rahim. Jika tidak dibuahi, sel telur akan bergerak terus, Bersama dengan sebagian dinding

rahim, menandai dimulainya hari ke-1 pada siklus berikutnya.

Siklus menstruasi, rata-rata, berlangsung dari 21-35 hari, siklus menstruasi yang biasa dimulai lapisan uterus terlepas. Rata-rata kehilangan darah seluruh periode sekitar 40 mililiter, dari tingkat rendah selama aliran, *estrogen* naik ke puncak siklus pertengahan selama 9-20 hari. Selanjutnya, puncak hipofisis *Luteinizing Hormon (LH)* memicu pelepasan sel telur, yang disebut sebagai ovulasi, setelah ovulasi, produksi *progesteron* naik tajam sementara *estrogen* berkurang minimal sampai keduanya berkurang pada periode berikutnya. Luteal, juga dikenal sebagai pasca ovulasi, fase biasanya berlangsung 10-14 hari (Webster, 2021).

Hormon pelepas *gonadotropin (GnRH)* dari *hipotalamus* mengontrol dua siklus. Hormon utama yang berfluktuasi di seluruh rahim dan siklus *ovarium* adalah hormon perangsang *folikel (FSH)*, hormon *luteinizing (LH)*, yang dilepaskan dari kelenjar hipofisis anterior, dan *estrogen* steroid jenis kelamin wanita (*estriol, estrone dan p-estradiol*), dan *progesteron*, yang dilepaskan oleh *korpus luteum (uterus)*. *FSH* dan *LH*, yang mendorong stimulasi ovulasi dan perkembangan *folikel ovarium*, dilepaskan dari hipofisis anterior untuk memulai produksi *folikel* dan mendorong ovulasi dalam siklus *ovarium* (Webster, 2021).

Peran *FSH* adalah untuk merangsang perkembangan *folikel ovarium*, yang mengeluarkan *estrogen*, sehingga *LH* dapat mengembangkan *folikel ovarium* lebih lanjut. *Luteinizing hormon* juga membantu memulai ovulasi dan merangsang produksi empat hormon utama *corpus luteum: estrogen, progesteron, inhibin, dan relaxin* (berguna untuk melahirkan) (Webster, 2021).

Menstruasi adalah endometrium uterus melepaskan keluarnya sel yang sekarat, yang mengandung sekitar 50 hingga 150 ml darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel karena menurunnya kadar *estrogen* dan *progesteron* di dalam rahim. Awal menstruasi, kadar *FSH* meningkat untuk merangsang perkembangan *folikel* primer, yang menghasilkan kadar *estrogen* yang rendah. Pada akhir menstruasi siklus, *folikel* primer ini telah berkembang menjadi *folikel* sekunder atau tumbuh, yang terdiri dari oosit sekunder dan beberapa lapisan sel epitel berbentuk kubus yang berasal dari sel epitel berbentuk kubus di sekitar *folikel* primer. Pada awal fase ini, level *FSH* sedikit lebih tinggi untuk merangsang pengembangan *folikel* dan memungkinkan sekresi *estrogen* oleh *folikel* (Cruteau, 2018).

Hanya satu dari *folikel* yang jatuh tempo telah mencapai kematangan. *Folikel* yang tumbuh melepaskan *estrogen*, merangsang proses atresia, yang merupakan penghambat negatif Sekresi *FSH* menyebabkan *folikel* yang kurang berkembang berhenti tumbuh dan berdegenerasi. *Folikel* yang satu ini matang menjadi *folikel ovarium vesikular*, atau *graafian*, atau *folikel* matang, sementara itu meningkatkan produksi *estrogen*. Tepat sebelum ovulasi, peningkatan jumlah *LH* adalah kadar *estrogen* yang disekresi dan melengkung berada pada titik tertinggi, memungkinkan penebalan dinding endometrium. Tingkat *estrogen* yang tinggi ini memberikan efek umpan balik positif, menstimulasi hormon hipofisis anterior untuk melepaskan *LH* dan GnRH, yang mempromosikan pelepasan lebih banyak *LH*. Peningkatan jumlah *LH* ini memicu ovulasi. Ovulasi, yang biasanya terjadi pada hari ke 14 dari siklus rata-rata, adalah

pelepasan *folikel ovarium* vesikular matang dan oosit sekunder ke dalam rongga panggul (Cruteau, 2018).

Butuh sekitar 20 hari (mulai enam hari terakhir dari siklus sebelumnya) untuk *folikel* berkembang menjadi *folikel ovarium* vesikular dewasa dan menunggu dalam tabung rahim. Setelah ovulasi terjadi, bekuan darah terbentuk untuk menghancurkan *ovarium* vesikular *folikel* untuk menjadi hemorrhagicum dan diserap oleh sel-sel *folikel* untuk terbentuk corpus luteum, dengan bantuan *LH*, *corpus luteum* mengeluarkan *estrogen* dan *progesteron*. Ini menandakan waktu setelah ovulasi dan sebelum menstruasi berikutnya, juga dikenal sebagai fase postovulasi. Fase ini biasanya berlangsung sekitar 14 hari dalam siklus 28 hari. Dalam siklus *ovarium*, ini juga dikenal sebagai luteal tahap; dalam siklus menstruasi ini juga disebut fase sekretori. Selama fase ini, produksi *progesteron* tinggi hingga siapkan endometrium untuk menerima sel telur yang dibuahi (Cruteau, 2018).

C. Gangguan Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi yang normal terjadi setiap 21–35 hari dengan lama menstruasi sekitar 4–7 hari. Namun terkadang, siklus menstruasi ini bisa terganggu. Gangguan menstruasi bisa berupa perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi tidak teratur, menstruasi terjadi lebih dari 7 hari, tidak menstruasi lebih dari 3 bulan, atau bahkan tidak pernah haid sama sekali. Gangguan menstruasi yang termasuk kedalam siklus menstruasi yang tidak normal adalah perubahan pada siklus menstruasi dan perubahan jumlah darah menstruasi (Bull et al., 2019).

Gangguan menstruasi merupakan kondisi yang merujuk pada kelainan siklus menstruasi. Gangguan yang

muncul pun akan berbeda pada masing-masing orang, seperti pendarahan berlebihan, rasa nyeri berlebihan, kacaunya siklus menstruasi, atau darah yang keluar dengan volume yang terlalu sedikit. Sejumlah gangguan menstruasi tersebut kerap terjadi pada remaja dengan sejumlah penyebab. Perubahan pada siklus menstruasi ada 3 yaitu:

1. Polimenorea

Polimenorea merupakan siklus menstruasi yang lebih pendek yaitu kurang dari 21 hari, menjadi pendeknya masa luteal.

Bila kondisi polimenorea disertai dengan jumlah darah haid yang cukup banyak, terlebih tidak ditangani dengan baik, penderitanya rentan mengalami anemia.

Tanda Polimenorea

Polimenorea merupakan salah satu jenis perdarahan rahim abnormal atau abnormal uterine bleeding (AUB). Maknanya, seorang wanita dikatakan mengalami polimenorea jika ada gangguan pada frekuensi, durasi, serta jumlah darah yang keluar pada saat menstruasi. Beberapa tandanya adalah:

- a. Rentang dari hari pertama haid menuju haid berikutnya lebih cepat, bahkan bisa hanya berlangsung 8–10 hari atau lebih, tetapi kurang dari 21 hari
- b. Durasi haid bisa berlangsung lebih dari 8 hari
- c. Darah haid keluar sangat banyak, lebih dari biasanya

D. Penyebab Polimenorea

Kondisi ini bisa menjadi tanda adaptasi hormonal bagi perempuan yang baru saja pubertas. Sebab, siklus haid memang normalnya belum teratur selama 1–2 tahun setelah haid pertama. Akan tetapi, jika terjadi pada perempuan dewasa, polimenorea erat kaitannya dengan masalah pada hormon atau organ reproduksi, antara lain:

1. Gangguan hormon

Polimenorea umum terjadi pada wanita yang mengalami penyakit tiroid, terutama kondisi hormon tiroid yang terlalu rendah (hipotiroidisme). Selain itu, wanita yang mengalami polycystic ovarian syndrome (PCOS) juga rentan mengalami gangguan siklus menstruasi, termasuk polimenorea.

2. Stres

Ketika stres, tubuh merespons dengan mengeluarkan hormon kortisol atau hormon stres. Hormon ini dapat mengganggu fungsi dan kerja sistem endokrin yang memproduksi hormon reproduksi, salah satunya estrogen. Akibatnya, siklus haid menjadi tidak teratur, termasuk lebih pendek seperti yang terjadi pada polimenorea.

3. Efek samping obat

Konsumsi obat, seperti kortikosteroid, obat pengencer darah, pil kontrasepsi, atau terapi obat yang mengandung hormon diketahui bisa mengganggu siklus haid sehingga membuatnya menjadi tidak teratur. Pemakaian kontrasepsi hormon berupa IUD juga diketahui berisiko mengiritasi rahim, sehingga memicu terjadinya perdarahan atau polimenorea.

4. Penurunan berat badan drastis

Berat badan turun secara drastis, baik tanpa alasan jelas maupun karena gangguan makan, juga dapat mengganggu siklus haid. Hal ini karena berat badan yang terlalu kurus dapat mengganggu fungsi dan kerja hormon dalam siklus menstruasi sehingga memicu terjadinya polimenorea.

5. Transisi menuju menopause

Wanita usia 30–40 tahun umumnya akan mengalami transisi menuju menopause, yang disebut juga perimenopause. Pada masa ini, hormon yang berperan dalam menstruasi akan naik-turun. Inilah sebabnya siklus haid bisa lebih pendek seperti polimenorea, meskipun beberapa wanita juga bisa mengalami siklus yang lebih panjang.

6. Infeksi menular seksual (IMS)

Polimenorea juga bisa dipicu oleh infeksi menular seksual, seperti gonore atau klamidia. Hal ini karena penyebab IMS bisa menyebar dan menginfeksi rahim serta saluran penghubung indung telur dan rahim (tuba falopi).

7. *Penyakit pada organ reproduksi*

Masalah kesehatan pada organ reproduksi sering kali menjadi penyebab polimenorea. Beberapa kondisinya meliputi polip pada serviks atau dinding rahim, tumor rahim jinak, endometriosis, hingga kanker serviks atau kanker rahim.

Siklus haid lebih pendek juga bisa dipicu oleh peradangan panggul, yang umumnya berawal dari infeksi menular seksual tanpa penanganan yang baik.

Oligomenorea

Oligomenorea adalah siklus haid lebih panjang, lebih dari 35 hari. Hal ini karena masa proliferasi lebih panjang dari biasa. Oligomenorea adalah kondisi ketika seorang wanita jarang sekali mengalami menstruasi, yakni jika siklus menstruasinya lebih dari 35–90 hari atau mendapat haid kurang dari 8–9 kali dalam kurun waktu setahun.

Oligomenorea sering dialami remaja yang baru memasuki pubertas dan wanita yang memasuki masa menopause. Gangguan menstruasi ini merupakan dampak dari aktivitas hormon yang sedang tidak stabil di masa-masa tersebut.

Di samping itu, ada beberapa hal lain yang mungkin jadi penyebab *oligomenorrhea*, di antaranya:

1. Penggunaan kontrasepsi hormonal, seperti pil KB atau KB suntik
2. Sering melakukan olahraga atau aktivitas fisik berat
3. Gangguan ovulasi
4. Penyakit tertentu, seperti diabetes, penyakit tiroid, dan sindrom polikistik ovarium (PCOS)
5. Gangguan makan, seperti anoreksia nervosa dan bulimia
6. Masalah psikologis, seperti stres dan depresi
7. Efek samping obat-obatan tertentu, seperti antipsikotik dan antiepilepsi

Amenorea

Amenorea dibagi menjadi 2 yaitu, amenorea primer dan amenorea sekunder. Amenorea primer apabila seorang perempuan berumur 18 tahun ke atas tetapi belum pernah mendapatkan haid, sedangkan amenorea sekunder pernah mendapat haid tetapi kemudian sedikitnya 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkannya lagi. Sedangkan Perubahan

jumlah darah terdapat 2 yaitu: 1. Hipermenorea atau menoragia. Hipermenorea adalah pendarahan haid yang lebih banyak dari normal (lebih dari 7 hari).

Kedua jenis amenorea ini memiliki penyebab yang berbeda. Amenorea primer dapat disebabkan oleh kelainan genetik, gangguan otak yang mengatur hormon menstruasi, atau masalah pada indung telur (ovarium) atau rahim.

Sementara itu, penyebab amenorea sekunder adalah:

1. Menyusui
2. Menopause
3. Penurunan berat badan yang berlebihan
4. Penyakit tertentu, seperti penyakit tiroid, *polycystic ovarian syndrome (PCOS)*, dan tumor otak di bagian kelenjar pituitari atau hipofisis
5. Gangguan rahim, seperti miom atau polip dalam rahim
6. Stres berat
7. Efek samping obat-obatan, seperti kemoterapi dan antidepresan
8. Penggunaan kontrasepsi, seperti pil KB, KB suntik, dan IUD

Selain itu, kekurangan gizi atau malnutrisi dan olahraga yang berlebihan juga bisa menyebabkan wanita mengalami amenorea

Hipomenorea

Hipomenorea adalah pendarahan haid yang lebih pendek dari biasa dan/atau lebih kurang dari biasa (kurang dari 3 hari) penyebabnya kemungkinan gangguan hormonal, kondisi wanita dengan penyakit tertentu.

E. Penyebab Hipomenorea

Ada berbagai kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami hipomenorea, antara lain:

1. Usia

Hipomenorea umumnya dialami oleh remaja yang baru mengalami menstruasi pertama (menarche) dan wanita yang berada di masa pramenopause. Kondisi ini terjadi karena kadar hormon yang memengaruhi siklus menstruasi mengalami perubahan keseimbangan pada rentang usia tersebut. Dengan alasan inilah usia dianggap sebagai salah satu penyebab hipomenorea.

2. Berat badan

Berat badan kurang maupun perubahan berat badan yang terjadi secara drastis diketahui dapat mengganggu keseimbangan hormon menstruasi dan menyebabkan terjadinya perubahan siklus haid, termasuk hipomenorea.

3. Olahraga yang terlalu berat

Berolahraga rutin adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Namun, melakukan olahraga yang terlalu berat dengan intensitas yang melebihi kemampuan tubuh justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk hipomenorea, dan ketidakseimbangan hormon menstruasi.

4. Stres

Stres akan memicu pelepasan hormon stres yang kemudian memengaruhi keseimbangan hormon menstruasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan menstruasi, termasuk hipomenorea, amenorrhea, atau bahkan tidak mens sama sekali. Namun, hipomenorea yang disebabkan oleh stres akan sembuh setelah stres teratasi.

5. Efek samping alat kontrasepsi

Hipomenorea juga bisa terjadi saat wanita menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti pil KB atau suntik KB. Kontrasepsi hormonal bekerja dengan cara mencegah pelepasan sel telur. Ketika tidak ada sel telur yang dilepaskan, dinding rahim tidak akan menebal dan menyebabkan darah menstruasi menjadi sangat sedikit, bahkan tidak berdarah sama sekali.

6. Hamil

Saat hamil, wanita tidak akan mengalami menstruasi. Namun, pada awal kehamilan, beberapa wanita bisa saja mengalami hipomenorea, yang sering disalahartikan sebagai menstruasi. Bercak darah yang lebih sedikit pada awal kehamilan ini disebabkan oleh pendarahan implantasi. Kondisi ini biasanya berlangsung tidak lebih dari 2 hari.

7. Kondisi medis tertentu

Meskipun umumnya tidak berbahaya, hipomenorea tetap harus diwaspadai jika berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini bisa menandakan adanya kondisi medis tertentu, seperti PCOS maupun sindrom Asherman.

F. Hormon Pengendali Proses Menstruasi

Dalam buku manajemen kesehatan menstruasi tahun 2020 menjelaskan bahwa sistem hormon merupakan salah satu faktor terpenting dalam siklus menstruasi. Sistem hormon lah pengendali proses menstruasi adalah:

1. Hormon kelenjar hipofisis-hipotalamus

Menjelang akhir siklus menstruasi yang normal, kadar estrogen dan progesteron dalam darah menurun. Kadar hormon ovarium yang rendah dalam darah ini menstimulasi hipotalamus untuk mensekresi Gn-RH.

Gonadotropin releasing hormon (Gn-RH) menstimulasi sekresi FSH. Folikel stimulating hormon (FSH) menstimulasi perkembangan folikel dan produksi estrogennya. Kadar estrogen mulai menurun dan Gn-RH, hipotalamus memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan LH. Lutenizing hormone (LH) mencapai puncak pada sekitar hari ke-13 atau ke-14 dari siklus 28 hari. Apabila tidak terjadi fertilisasi dan implantasi, korpus luteum menyusut, oleh karena itu kadar estrogen dan progesteron menurun, maka terjadi menstruasi.

2. Hormon ovarium

Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pemeliharaan organ-organ serta mempercepat proses pematangan folikel ke bentuk perkembangan lebih lanjut dan memastikan dinding rahim menebal sebagai persiapan tempat implantasi bagi sel telur yang sudah di buahi. Estrogen memainkan peranan penting dalam perkembangan payudara dan dalam perubahan siklus bulanan dalam uterus. Progesteron juga penting dalam mengatur perubahan yang terjadi dalam rahim selama siklus menstruasi. Progesteron merupakan hormon yang paling penting untuk menyiapkan endometrium untuk berdiamnya sel telur yang telah dibuahi.

G. Pre Menstruation Syndrom (PMS)

Sindrom premenstruasi adalah kumpulan gejala tidak menyenangkan berupa gejala fisik, emosional dan psikologis yang terkait dengan siklus menstruasi wanita. Biasa muncul 7-14 hari sebelum haid. Gejala tersebut akan menghilang setelah haid muncul beberapa hari (Nourjah, 2008 dalam Nurmiaty, 2021).

Pre Menstruation Syndrom (PMS) meliputi gejala psikis dan fisik, yaitu (The American college of Obstetricians and Gynecologist, 2015):

1. Gejala emosional: hormon estrogen dan progesterone menurun menjelang menstruasi. Penurunan hormon ovarium juga mempengaruhi produksi hormon di otak, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi hormon yang mempengaruhi suasana hati atau emosi. Gejala emosional meliputi depresi, mudah marah, sensitif, mudah menangis, cemas, bingung, gangguan konsentrasi dan insomnia.
2. Wanita merasa tubuhnya bertambah gemuk, hal ini dikarenakan peningkatan estrogen sehingga menyebabkan retensi cairan sehingga badan terasa agak bengkak.
3. Gejala fisik yang dialami seperti nyeri sendi dan otot, sakit kepala, cepat lelah, perut kembung, nyeri payudara, jerawat, diare atau sembelit, kaki dan tangan bengkak, gangguan klit, gangguan saluran cerna, nyeri perut.

Beberapa faktor risiko sindroma premenstruasi antara lain diet, defisiensi zat gizi makro dan mikro, status perkawinan, usia, stress, kebiasaan merokok dan minum

alkohol dan kurang olahraga. Tipe dan jenis-jenis sindroma premenstruasi adalah:

- a. PMS tipe A (anxiety) ditandai dengan gejala seperti rasa cemas, sensitif, saraf tegang, perasaan labil.
- b. PMS tipe H (hyperhydration) memiliki gejala edema (pembengkakan), perut kembung, nyeri pada buah dada, pembengkakan tangan dan kaki, peningkatan berat badan sebelum haid.
- c. PMS tipe C (craving) ditandai dengan rasa lapar ingin mengonsumsi makanan yang manis-manis (biasanya coklat) dan karbohidrat sederhana (biasanya gula).
- d. PMS tipe D (depression) ditandai dengan gejala rasa depresi, ingin menangis, lemah, gangguan tidur, pelupa, bingung, sulit dalam mengucapkan kata-kata (verbalisasi), bahkan kadang-kadang muncul rasa ingin bunuh diri atau mencoba bunuh diri.

Pada remaja, gejala PMS banyak terjadi pada tipe C. Hal ini dapat mengganggu kegiatan sehari-hari mereka pada remaja yang sebagian besar adalah pelajar untuk berkonsentrasi dan kesulitan dalam menerima bahan pembelajaran yang diberikan

BAB 4

DISMENOREA

A. Pengertian Dismenore

Dismenore (dysmenorrhea) berasal dari bahasa Yunani, kata dys yang berarti sulit, nyeri, abnormal, meno yang berarti bulan, dan orrhea yang berarti aliran. Dismenore adalah kondisi medis yang terjadi sewaktu haid atau menstruasi yang dapat mengakibatkan nyeri perut dan pinggang, tidak enak badan, mudah emosi dan lelah serta dapat mengganggu aktivitas (Judha, 2019).

Gangguan menstruasi yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri sebelum, saat atau sesudah menstruasi. Nyeri haid terjadi karena peningkatan prostaglandin dalam darah sehingga menyumbat aliran darah dan merangsang peningkatan kontraksi uterus. Bila nyerinya ringan dan masih dapat beraktivitas berarti masih wajar. Namun, bila nyeri yang terjadi sangat hebat sampai mengganggu aktivitas ataupun tidak mampu melakukan aktivitas, maka termasuk pada gangguan. Nyeri dapat dirasakan di daerah perut bagian bawah, pinggang bahkan punggung (Judha, 2019).

Gejala dismenore setiap perempuan berbeda. Namun tanda dan gejala dismenore paling khas yaitu kram perut bagian bawah, punggung bawah hingga paha dalam. Keluhan ini akan berdampak pada aktivitas sehari-hari baik di sekolah maupun di tempat kerja. Tidak sedikit penderita yang merasakan nyeri berat sehingga terpaksa

meninggalkan aktivitasnya untuk beristirahat beberapa jam atau hari. Seringkali penderita mengatasi dismenore dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri yang di jual bebas dipasaran tanpa tahu efek samping dari obat tersebut.

Kejadian dismenore primer di dunia rata- rata lebih dari 50% di setiap negara.³ Persentase kejadian dismenore di Amerika sekitar 85%, Italia sekitar 84,1% dan di Australia sekitar 80%.⁴ Di Indonesia persentase dismenor sebanyak 64,25% yang terdiri dismenore primer sebanyak 54,88% dan 9,36% dismenore sekunder.

Dismenore yang sering terjadi adalah dismenore fungsional (wajar) yang terjadi pada hari pertama atau menjelang hari pertama. Biasanya dismenore akan menghilang atau membaik seiring hari berikutnya menstruasi. Dismenore yang non fungsional (abnormal) menyebabkan nyeri hebat yang dirasakan terus menerus, baik sebelum, sepanjang menstruasi bahkan sesudahnya (Judha, 2019).

B. Etiologi Dismenore

Penyebab dismenore bermacam-macam, bisa karena penyakit (radang panggul), endometriosis, tumor atau kelainan uterus, selaput dara atau vagina tidak berlubang, stress atau cemas yang berlebihan. Penyebab fisiologis nyeri haid terjadi karena peningkatan prostaglandin dalam darah sehingga menyumbat aliran darah dan merangsang peningkatan kontraksi uterus.(Judha, 2019).

Penyelidikan dalam tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan kadar prostaglandin penting peranannya sebagai penyebab terjadinya nyeri menstruasi. Terjadinya

spasme miometrium dipacu oleh zat dalam darah menstruasi, mirip lemak alamiah yang kemudian diketahui sebagai prostaglandin, kadar zat ini meningkat pada keadaan nyeri menstruasi dan ditemukan di dalam otot uterus (Dawood, 2019).

Ditemukan kadar PGE2 dan PGF2 α sangat tinggi dalam endometrium, miometrium dan darah menstruasi wanita yang menderita nyeri menstruasi primer. Prostaglandin menyebabkan peningkatan aktivitas uterus dan serabut serabut saraf terminal rangsang nyeri. Kombinasi antara peningkatan kadar uterus sampai 400 mmHg dan menyebabkan kontraksi miometrium yang hebat. Prostaglandin yang dihasilkan uterus berperan dalam menimbulkan hiperaktivitas miometrium. Kontraksi miometrium yang disebabkan oleh prostaglandin akan mengurangi aliran darah, sehingga terjadi iskemia sel-sel miometrium yang mengakibatkan timbulnya nyeri spasmodik. Jika prostaglandin dilepaskan dalam jumlah berlebihan ke dalam peredaran darah, maka akan timbul efek sistemik seperti diare, mual, muntah (Harel, 2022).

C. Klasifikasi Dismenore

Dismenore dapat digolongkan berdasarkan jenis nyeri dan ada tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati (Judha, 2019).

Dismenore berdasarkan jenis nyeri adalah:

1. Dismenore spasmodik

Dismenore spasmodik adalah nyeri yang dirasakan dibagian bawah perut dan terjadi sebelum atau segera setelah haid dimulai. Dismenore spasmodik dapat dialami

oleh wanita muda maupun Wanita berusia 40 tahun keatas. Sebagian wanita yang mengalami dismenore spasmodik, tidak dapat melakukan aktivitas

Tanda dismenore spasmodik, antara lain:

- a. Pingsan
- b. Mual
- c. Muntah
- d. Dismenore spasmodik dapat diobati atau berkurang dengan melahirkan, walaupun tidak semua wanita mengalami hal tersebut

2. Dismenore kongestif

Dismenore kongestif dapat diketahui beberapa hari sebelum haid datang. Gejala yang ditimbulkan berlangsung 2 sampai 3 hari sampai kurang dari 2 minggu. Pada saat haid datang, tidak terlalu menimbulkan nyeri. Bahkan setelah hari pertama haid, penderita dismenore kongestif akan merasa lebih baik.

Gejala yang ditimbulkan pada dismenore kongestif, antara lain:

- a. Pegal pada bagian paha
- b. Sakit pada daerah payudara
- c. Lelah
- d. Merasa tersinggung
- e. Kehilangan keseimbangan

Dismenore diklasifikasikan sebagai dismenore primer dan sekunder. Dismenore primer adalah nyeri menstruasi yang tidak didasari kondisi patologis organik, dan biasanya terjadi pada beberapa tahun pertama setelah menarche. Diperkirakan 50% wanita pascapubertas pernah mengalami dismenore primer. Sedangkan dismenore sekunder adalah dismenore yang

didasari keadaan patologis pelvis maupun kondisi medis lain, terutama endometriosis. Dismenore sekunder lebih banyak ditemukan pada wanita usia lebih tua (>25 tahun).

Mekanisme timbulnya nyeri pada dismenore belum diketahui pasti, tetapi diduga karena hipersekresi prostaglandin dan leukotrien, serta peningkatan kontraktilitas pada uterus.

Dismenore primer murni tidak memerlukan tes atau pemeriksaan penunjang spesifik. Sedangkan dismenore sekunder dapat dicurigai bila dismenore berat segera setelah menarche atau dismenore yang progresif memburuk, abnormal uterine bleeding, infertilitas, tidak memberikan respons pada terapi medikamentosa, dan dispareunia. Selain itu, dismenore dengan riwayat keluarga endometriosis, anomali renal, maupun kelainan kongenital lainnya juga dapat dicurigai dismenore sekunder.

Dismenore berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati adalah:

a. Dismenore Primer

Dismenore primer yaitu nyeri saat menstruasi yang dialami perempuan usia subur dan tidak berhubungan dengan kelainan organ reproduksi. Dismenore primer memiliki ciri khas yaitu rasa nyeri timbul sejak 1-3 hari menstruasi dengan efek seperti nyeri perut bagian bawah, tidak enak badan, mudah emosi dan lelah, serta mengganggu aktivitas sehari-hari misalnya belajar. Keluhan sakitnya agar berkurang setelah wanita bersangkutan menikah dan hamil. Penyebabnya berkaitan dengan pelepasan sel-sel telur (ovulasi) dari ovarium sehingga dianggap berhubungan dengan gangguan keseimbangan hormon (Devi, 2020).

Dismenore primer Muncul semenjak haid perdana (menarch) serta keluhan sakit akanmengurang selepas menikah dan langsung hilang setelah hamil. Laurel D Edmundson (2006) menjelaskan, dismenore primer mempunyai ciri khusus meliputi: Waktu terjadinya 6-12 bulan selepas haid perdana (menarche). Nyeri perut bawah ataupun pelvis dimulai saat haid serta selesai setelah 8-72 jam. Nyeri paha pada sekitar anterior ataupun medial. Low back pain. Sakit kepala (headache). Diare (diarrhea). Mual (nausea) ataupun muntah (vomiting).

Kondisi ini tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi. Keadaan ini umumnya disebabkan peningkatan dari hormon prostaglandin, yang diproduksi pada lapisan dari rahim. Peningkatan prostaglandin memicu kontraksi dari uterus atau rahim. Secara alami, rahim cenderung memiliki kontraksi lebih kuat semasa haid. Kontraksi rahim ini dapat menimbulkan keluhan nyeri.

Selain itu, kontraksi rahim yang terlalu kuat dapat menekan pembuluh darah sekitar dan menyebabkan kurangnya aliran darah ke jaringan otot dari rahim. Jika jaringan otot ini mengalami kekurangan oksigen akibat kekurangan suplai darah, keluhan nyeri dapat timbul.

b. Dismenore sekunder

Dismenore sekunder biasanya baru muncul, jika ada penyakit atau kelainan organ reproduksi yang menetap seperti infeksi rahim, kista, polip, atau tumor, serta kelainan kedudukan rahim yang mengganggu organ dan jaringan di sekitarnya (Kusmiran, 2019). Penderita dismenore sekunder biasanya sampai tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dismenore sekunder

dapat diatasi hanya dengan mengobati atau menangani penyakit atau kelainan yang menyebabkannya (Sinaga dkk., 2019).

Dismenore Sekunder Berhubungan dengan hormon prostaglandin. Prostaglandin berperan untuk membuat kontraksi otot rahim meningkat. Secondary dysmenorrhea (dismenore sekunder) bisa berlangsung kapan pun selepas menarche, tetapi paling kerap timbul pada umur 20 hingga 30-an, selepas sejumlah tahun normal relatively painless cycles (siklus tanpa nyeri). Meningkatnya prostaglandin bisa berpengaruh dalam secondary dysmenorrhea, tetapi secara pengertiannya diharuskan terdapat penyakit pelvis yang menemani. Penyebab secara umumnya meliputi: fibroid (leiomyomata), endometriosis, chronic pelvic inflammatory disease, polip endometrium, adenomyosis, serta pemakaian Intrauterine Device (IUD) ataupun alat kontrasepsi. Laurel D Edmundson (2006) menjelaskan, secondary dysmenorrhea mempunyai ciri khusus meliputi:

- 1) Terjadi dalam umur 20 hingga 30-an, selepas siklus haid yang relatif tidak nyeri dalam masa lampau
- 2) Tidak teraturnya perdarahan ataupun heavy menstrual flow (banyaknya darah haid)
- 3) Infertilitas
- 4) Rasa nyeri ketika seks (dyspareunia)
- 5) Nyeri pelvis ataupun perut bawah ketika tidak haid
- 6) Vaginal discharge
- 7) Tidak berkurangnya nyeri melalui terapi NSAIDs (nonsteroidal anti inflammatory drugs)

Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menyelidiki etiologi apabila terdapat kecurigaan adanya

dismenore sekunder. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan mencakup pemeriksaan laboratorium, USG abdomen atau USG transvaginal, histerosalpingografi, histeroskopi, atau laparoskopi.

Tata laksana dismenore secara umum bertujuan untuk memperingan nyeri serta menghambat proses yang mendasari keluhan. Derajat keparahan dismenore dapat ditentukan berdasarkan skala nyeri dan tingkat keterbatasan aktivitas harian. Meskipun dismenore tidak mengancam jiwa, dismenore sering dikaitkan dengan dampak emosional, psikologis, dan fungsional yang signifikan. Hal ini dapat membebani wanita dan mengganggu kualitas hidupnya. Dismenore merupakan penyebab utama morbiditas ginekologi pada wanita usia subur tanpa memandang usia, etnis, dan status ekonomi.

D. Faktor penyebab Dismenore Primer

Penyebab adanya dismenorea pada remaja putri meliputi:

1. Usia menarche

Menarche adalah suatu keadaan ketika seorang wanita mengalami menstruasi yang pertama kali. Pada remaja putri menarche yang lebih awal dari usia normal menjadi salah satu faktor terjadinya dismenorea primer. Menarche pada usia lebih awal menyebabkan alat-alat reproduksi belum berfungsi secara optimal, sehingga belum siap mengalami perubahan dan masih terjadi penyempitan pada leher rahim, maka akan timbul rasa sakit saat menstruasi (Widjanarko, 2017 dalam Kristianingsih, 2018).

2. Status gizi

Status gizi merupakan salah satu faktor resiko terjadinya dismenore primer, seseorang yang memiliki

status gizi overweight berisiko untuk terkena dismenorea karena semakin banyak lemak semakin banyak pula prostaglandin yang dibentuk, peningkatan prostaglandin dalam sirkulasi darah diduga sebagai penyebab dismenorea (Arisman, 2019).

3. Aktivitas olahraga

Aktivitas olahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, salah satunya adalah untuk meringankan nyeri haid (dismenorea) pada wanita. Latihan olahraga mampu meningkatkan produksi endorfin (penghilang rasa sakit alami tubuh), dapat meningkatkan kadar serotonin. Membiasakan olahraga ringan dan aktivitas fisik secara teratur pada saat sebelum dan selama haid dapat membuat aliran darah pada otot sekitar rahim menjadi lancar, sehingga rasa nyeri dapat teratasi atau berkurang. (Safitri, Rahman, dan Hasanah, 2018).

4. Stres

Seseorang dengan keadaan stres, akan memproduksi hormon kortisol dan prostaglandin yang berlebihan pada tubuhnya. Hormon ini dapat menyebabkan peningkatan kontraksi uterus secara berlebihan sehingga mengakibatkan rasa nyeri saat menstruasi. Selain itu hormon adrenalin juga meningkat dan menyebabkan otot tubuh menjadi tegang termasuk otot rahim dan menjadikan nyeri saat menstruasi (Sari dan Nurdin, 2019).

E. Derajat Dismenore

Intensitas nyeri (skala nyeri) adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan

kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda (Septiani, 20118).

Menurut Howard dalam Leppert (2020) derajat nyeri dismenore dibagi menjadi tiga tingkat keparahan yaitu:

1. Dismenore ringan

Seorang akan mengalami nyeri atau nyeri masih dapat ditolerir karena masih berada pada ambang rangsang, berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan kerja sehari-hari. Dismenore ringan terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 1-3.

2. Dismenore sedang

Seseorang mulai merespon nyerinya dengan merintih dan menekan- nekan bagian yang nyeri, diperlukan obat penghilang rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan kerjanya. Dismenore sedang terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 4-6.

3. Dismenore berat

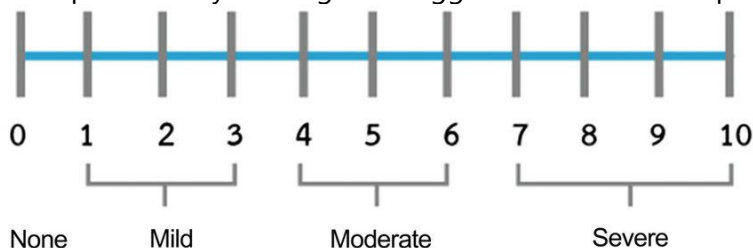
Seseorang mengeluh karena adanya rasa terbakar dan ada kemungkinan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan biasa dan perlu istirahat beberapa hari, dan dapat disertai sakit kepala, migran, pingsan, diare, rasa tertekan, mual dan sakit perut. Dismenore berat terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 7-10.

F. Derajat Pengukuran Nyeri (Numeric Rating Scale)

Intensitas nyeri (skala nyeri) adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda (Septiani,

2019). Menurut Hidayat (2019), beberapa instrumen pengkajian nyeri yang sering digunakan adalah:

1. Skala Penilaian Numerik (Numerical Rating Scale / NRS)
NRS lebih digunakan sebagai pengganti atau pendamping VDS. Dalam hal ini klien memberikan penilaian nyeri dengan menggunakan skala 0 sampai 10.



Gambar 4.1 numeric rating scale (Septiani, 2019).

- a. 1-3 (nyeri ringan): terasa kram pada perut bagian bawah, tetapi masih dapat melakukan aktivitas, dapat berkomunikasi dengan baik, dan masih dapat berkonsentrasi.
- b. 4-6 (nyeri sedang): terasa kram pada perut bagian bawah, wajah menyeringai, mendesis, menyebar ke area pinggang, kurang nafsu makan, sebagian aktivitas terganggu, sulit konsentrasi, memegang area yang nyeri, dan dapat mendeskripsikan nyerinya.
- c. 7-9 (nyeri berat terkontrol): terasa kram berat pada perut bagian bawah, wajah menyeringai, menangis, nyeri menyebar ke pinggang, paha atau punggung, tidak kuat beraktivitas, terkadang tidak mengikuti perintah tetapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjuk lokasi nyeri, mual, tidak nafsu makan.

- d. 10 (nyeri sangat berat/ tidak terkontrol): terasa kram yang berat sekali pada perut bagian bawah, nyeri menyebar ke pinggang, kaki dan punggung, sakit kepala, mual, muntah, tidak mau makan, lemas, tidak dapat beraktivitas, tangan menggepal, mengatupkan gigi, menjerit terkadang sampai pingsan, pasien tidak mampu lagi berkomunikasi

BAB 5

TERAPI NON KONVESIONAL

A. Pengertian Terapi Non Konvensional

Terapi komplementer adalah terapi dari cabang bidang ilmu kesehatan yang fokus mempelajari mengenai metode penanganan berbagai jenis penyakit dengan memakai teknik tradisional. Cara pengobatan pada terapi komplementer ini tidak memakai obat-obatan kimia melainkan pengobatan ini memakai berbagai macam jenis obat herbal serta terapi. Sebagai salah satu metode penyembuhan penyakit, terapi komplementer dijadikan alternatif untuk melengkapi pengobatan medis secara konvensional maupun sebagai alternatif selain pengobatan obat-obatan farmakologi (Ayuningtyas, 2019).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terapi diartikan sebagai suatu usaha guna mengembalikan kesehatan orang yang sakit, pengobatan suatu penyakit, serta perawatan terhadap suatu penyakit. Terapi komplementer ini bersifat melengkapi. Pengobatan ini dilakukan dengan maksud untuk menyempurnakan pengobatan medis serta bersifat rasional sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia (Purwanto, 2018).

Pendapat lain mengemukakan bahwa terapi komplementer merupakan pengembangan terapi tradisional dan sebagian dari terapi itu ada yang padukan dengan jenis terapi modern yang mempengaruhi kondisi keharmonisan. Seorang individu baik dari segi biologis, psikologis, serta

spiritual. Hasil dari terapi yang telah dintegrasikan itulah ada yang berhasil lulus pengujian klinis sehingga setara dengan obat atau terapi modern. Keadaan ini sejalan dengan prinsip keperawatan yang melihat manusia sebagai makhluk holistic (bio, psiko, social, serta spiritual) (Rufaida, Wardini Sari, 2018).

Kesuksesan obat alternatif ataupun terapi komplementer telah teruji oleh banyak penelitian yang menyajikan fakta bahwa terapi ini bisa membantu menghilangkan perasaan sakit serta mual. Namun kekurangannya bahwa tidak semua jenis pada terapi komplementer telah teruji melalui penelitian. Terapi komplementer dilakukan dengan menggunakan obat-obatan herbal maupun jenis terapi. Meskipun obat-obatan herbal ini dianggap sebagai obat alami, obat-obatan herbal ini sebaiknya harus dikonsumsi secara hati-hati karena dapat bereaksi dengan obat-obatan yang lain maupun obat-obatan kimia yang dikonsumsi (Ayuningtyas, 2019).

Dengan demikian pengertian terapi komplementer adalah pengobatan yang dilakukan melalui metode berbagai jenis terapi maupun menggunakan obat-obatan herbal yang dilakukan oleh tenaga ahli yang terlatih sehingga dapat melengkapi pengobatan konvensional dan dapat memberikan hasil pengobatan yang maksimal kepada penderita suatu penyakit (Ayuningtyas, 2019).

B. Pengertian Terapi Akupresure

Cara meredakan nyeri haid bisa dilakukan dengan pijat akupresur. Akupresur adalah pengobatan dengan teknik pemijatan menggunakan ibu jari atau ujung jari

di titik-titik tertentu pada tubuh seseorang untuk merangsang titik-titik energy.

Akupresur adalah cara pijat berdasarkan ilmu akupunktur atau dapat juga disebut akupunktur tanpa jarum pada titik-titik tertentu. Ilmu akupresur berasal dari Tionghoa yang sudah ada lebih dari 500 tahun lalu.

Akupresure kini sudah dikenal luas di Indonesia. Mekanisme kerja akupresure diketahui berdasarkan dari tiongkok. Pijat memijat merupakan kebiasaan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, sudah berakar dan berkembang luas sejak ratusan tahun. Pijat akupresure (acupressure) adalah cara pijat berdasarkan ilmu akupunktur (acupuncture) atau bisa juga disebut akupunktur tanpa jarum. Pemijatan dilakukan pada titik akupunktur dibagian tubuh tertentu untuk menghilangkan keluhan atau penyakit yang diderita (Oka Sukanta, 2020). Akupresure disebut juga dengan terapi totok atau tusuk jari adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu atau acupoint pada tubuh. Akupresure juga diartikan sebagai menekan titiktitik penyembuhan menggunakan jari secara bertahap yang merangsang kemampuan tubuh untuk penyembuhan diri secara alami (Setyowati, 2018)

C. Manfaat Akupresure

Titik-titik akupresure berada dipermukaan kulit yang memiliki kepekaan bioelektik Stimulasi terhadap titik-titik ini akan merangsang keluarnya endorpin, hormon pengurang rasa sakit. Sebagai hasilnya, rasa sakit akan diblok dan aliran darah dan oksigen ke area titik-titik tersebut meningkat. Hal ini akan merilekskan otot dan mendorong kesembuhan. Akupresure menghalangi sinyal rasa sakit ke otak melalui stimulasi ringan, menghalangi sensasi rasa sakit melalui syaraf spinal menuju otak. Stimulasi pada titik-titik akupresure tidak hanya dapat menghilangkan sumbatan pada jalur meredian, juga dapat menghilangkan aliran Qi, darah serta mengharmoniskan Yin dan Yang tubuh (Oka Sukanta, 2020). Akupuntur atau akupresure memanfaatkan rangsangan pada titik-titik akupuntur tubuh pasien, telinga atau kulit kepala untuk mempengaruhi aliran bioenergi tubuh yang disebut dengan Qi. Qi mengalir dalam suatu meredian (saluran) (Oka Sukanta, 2020).

Efek penekanan di titik akupresure di atas, akan berdampak pada produksi endorpin dalam tubuh. Endorpin adalah pembunuh rasa nyeri yang dihasilkan sendiri oleh tubuh. Pelepasan endorpin dikontrol oleh sistem saraf sensitif salah satunya dengan cara menekan pada titik akupresure. Pijatan/tekanan pada titik akupoint akan merangsang sistem endokrin untuk mengeluarkan sejumlah endorpin. Jika endorpin yang dikeluarkan/dilepaskan sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka rasa nyeri pada saat haid/dismenore dapat diatasi (Oka Sukanta, 2020).

Jadi inti pengobatan akupuntur/akupresure adalah mengembalikan sistem keseimbangan (homeostatis) tubuh yang terwujud dengan adanya aliran qi yang teratur dan

harmonis dalam meredian sehingga pasien sehat kembali. Dengan menguatkan qi daya tubuh menjadi baik, penyebab penyakit dapat dihilangkan secara tidak langsung Hilangnya penyebab penyakit dan kuatnya ci dapat mengembalikan keadaan yin dan yang sehingga penyakit bisa sembuh dan orang bisa menjadi sembuh kembali (Setyowati, 2018).

D. Cara Melakukan Akupresure

Pemijatan akupresur dilakukan dengan teknik penekanan yang secara umum dengan kekuatan 1,2kg/cm³. Penekanan ini secara praktis dilakukan dengan menggunakan ibu jari tangan sampai 1/3 ujung ujung jari kuku yang dilakukan sebanyak 30 kali hitungan. Penekanan yang dilakukan pada akupresur dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan serta dapat menggunakan minyak untuk memperlancar akupresur (Kemenkes RI, 2021).

Beberapa teknik umum yang dilakukan dalam pemijatan akupresur untuk menstimulasi titik tekan (Asep Achmad Hidayat, 2020):

1. Tonifying, merupakan penekanan dengan memperkuat chi yang lemah dengan menggunakan ibu jari atau menggunakan jari telunjuk ke titik akupoin dengan mantap dan stabil yang kemudian ditahan selama sekitar dua menit
2. Dispersing, merupakan gerakan dengan cara memutar atau arah keluar masuk yang dilakukan oleh ibu jari atau jari tangan dengan tujuan untuk memindahkan chi yang stagnan atau terhalang selama dua menit.
3. Menenangkan chi pada titik tekan dengan menggunakan telapak tangan untuk menutupi titik dan selanjutnya menggores area selama sekitar dua menit dengan lembut.

BAB 6

AKUPRESURE UNTUK DISMENORE

A. Pengaruh Pemijatan *Akupresure* Pada Dismenore

Pada terapi akupresure memiliki efek analgesik dan lebih efektif untuk mengurangi nyeri. Terapi akupresure dengan pemijatan titik-titik meridian berpengaruh dalam peningkatan kadar endorphen sehingga lebih cepat menurunkan rasa nyeri (Henri, 2018). Penekanan titik akupresure berpengaruh pada produksi endorphen yang merupakan pembunuhan rasa nyeri yang dihasilkan tubuh. Endorphen dilepaskan atas kontrol dari sistem saraf. Saraf yang sensitif terhadap nyeri dan rangsangan dari luar begitu dipicu dengan menggunakan teknik akupresure, akan menginstruksikan sistem endokrin untuk melepaskan sejumlah endorphen sesuai kebutuhan tubuh. Dengan hal tersebut, akupresur menjadi analgesik alami terhadap rasa nyeri yang sedang dirasakan pada saat dismenore (Hasanah et al., 2020).

Penurunan intensitas dismenore sesuai dengan gate control theory. Apabila implus besar yang ditransmisikan seperti rangsangan kulit, sentuhan, getaran, hangat dan dingin, serta sentuhan halus akan menghambat implus pada daerah substansi gelatinosa. Sensasi yang dibawa oleh serabut-serabut kecil akan berkurang atau bahkan tidak dapat merasakan nyeri. Kondisi tersebut mengacu pada "closed gate" (Mukhoirotin, Fatmawati, & Prihartini, 2018).

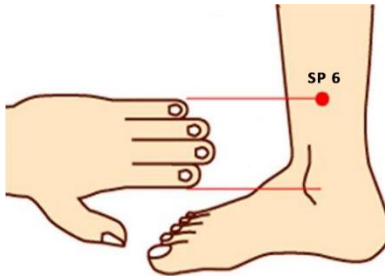
B. Titik akupresure untuk mengatasi dismenore

Akupresure pada dismenorea dapat dilakukan dengan pemijatan pada lokasi-lokasi yang berbeda, diantaranya (Kemenkes RI, 2020):

1. Terapi akupresure Titik Sp6

Akupresure yang dipergunakan pada penanganan dysmenorrhea adalah akupresure di titik SP6 (sanyinjiao). Titik SP6 yakni titik yang dipergunakan dalam menguatkan limpa, memulihkan keseimbangan Yin serta Yang, ginjal, hati, dan darah serta melancarkan suplai darah juga peredarannya. Akupresure sanyinjiao point tersebut memiliki keunikan, yakni lokasi bertemunya tiga meridian Y in kaki. Adapun riset dengan judul "Effects of SP6 acupressure on pain and menstrual distress in young women with dysmenorrhea" (2020) dalam Efriyanthi dkk (2020) menjabarkan oleh penyembuhan Tionghoa, rahim termasuk organ terkait ke ginjal serta jantung melewati jalur tertentu, juga suplai darah di hati disalurkan ke rahim. Bila penyalurannya darah hanya sedikit menuju hati. artinya penyalurannya juga sedikit menuju Rahim (Kemenkes RI, 2020)

Kondisi tersebutlah yang mengakibatkan teriadinya dysmenorrhea. Terapi akupresure sanyinjiao point bisa menolong melancarkan suplai darah juga peredarannya antara tiga bulanan (Wong, 2009 dalam Rahmawati dkk 2019).



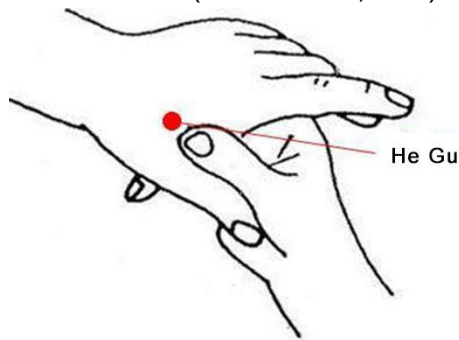
Gambar 6.1 Titik Sp6 (Rahmawati dkk 2022).

2. Terapi Akupresure Titik LI4

Akupresure titik hegu (LI4). Teknik akupresure pada daerah tangan (terletak di antara os metacarpal I dan II dari os II metacarpal radial tengah atau di permukaan punggung tangan antara ibu jari dan jari telunjuk kira-kira di tengah tulang metacarpal kedua). Terbukti dalam penelitian El-Gendy bahwa akupresure menurunkan intensitas nyeri dan kualitas nyeri saat menstruasi (Hasanah, Lestari, Novayelinda, & Deli, 2020), mengurangi lokasi nyeri dismenore serta mengurangi gejala yang menyertai dismenore pada remaja putri. Terbukti pula dengan penelitian Gita Kostania bahwa tingkat nyeri menstruasi pada kelompok eksperimen setelah dilakukan akupresure pada titik hegu mengalami penurunan dari tingkatan sedang menjadi ringan (Kostania, Kuswati, & Fitriyani, 2019).

Serta penelitian Mukhoirotin (2018) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan akupresure di titik hegu (LI4) terhadap penurunan intensitas nyeri haid (dismenore). Terkait dengan produksi prostaglandin pada fase luteal, akupresure diharapkan mampu melancarkan peredaran darah, sehingga prostaglandin ikut mengalir dalam peredaran darah dan tidak menumpuk pada uterus

dan akhirnya diharapkan dapat menurunkan rasa nyeri pada saat menstruasi (Mukhoirotin,2018).



Gambar 6.2 Titik LI4 (Mukhoirotin,2018).

Berdasarkan teori (Heni, 2022) yaitu pada terapi akupresure memiliki efek analgesik dan lebih efektif untuk mengurangi nyeri. Terapi akupresure dengan pemijatan titik-titik meridian berpengaruh dalam peningkatan kadar endorphen sehingga lebih cepat menurunkan rasa nyeri.

Penekanan titik akupresure berpengaruh pada produksi endorphen yang merupakan pembunuh rasa nyeri yang dihasilkan tubuh. Endorphen dilepaskan atas kontrol dari sistem saraf. Saraf yang sensitif terhadap nyeri dan rangsangan dari luar begitu dipicu dengan menggunakan teknik akupresure, akan menginstruksikan sistem endokrin untuk melepaskan sejumlah endorphen sesuai kebutuhan tubuh. Dengan hal tersebut, akupresure menjadi analgesik alami terhadap rasa nyeri yang sedang dirasakan pada saat dismenorea (Hasanah et al., 2020)

Penurunan intensitas dismenorea sesuai dengan gate control theory. Apabila implus besar yang

ditransmisikan seperti rangsangan kulit, sentuhan, getaran, hangat dan dingin, serta sentuhan halus akan menghambat implus pada daerah substansi gelatinosa. Sensasi yang dibawa oleh serabut-serabut kecil akan berkurang atau bahkan tidak dapat merasakan nyeri. Kondisi tersebut mengacu pada "closed gate".

Berdasarkan teori (Efriyanti et al,2020), akupresure yang dipergunakan pada penanganan dysmenorrhea adalah akupresure di titik SP6 (sanyinjiao). Titik SP6 yakni titik yang dipergunakan dalam menguatkan limpa, memulihkan keseimbangan Yin serta Yang, ginjal, hati, dan darah serta melancarkan suplai darah juga peredarannya. Akupresure sanyinjiao point tersebut memiliki keunikan, yakni lokasi bertemunya tiga meridian Y in kaki. Adapun riset dengan judul "Effects of SP6 acupressure on pain and menstrual distress in young women with dysmenorrhea" (2020) dalam Efriyanti dkk (2020) menjabarkan oleh penyembuhan Tionghoa, rahim termasuk organ terkait ke ginjal serta jantung melewati jalur tertentu, juga suplai darah di hati disalurkan ke rahim. Bila penyalurannya darah hanya sedikit menuju hati. artinya penyalurannya juga sedikit menuju rahim.

Hal ini sejalan dengan teori (Mukhoirotin, 2018), menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan akupresure di titik hegu (LI4) terhadap penurunan intensitas nyeri haid (dismenore). Terkait dengan produksi prostaglandin pada fase luteal, akupresure diharapkan mampu melancarkan peredaran darah, sehingga prostaglandin ikut mengalir dalam peredaran darah dan

tidak menumpuk pada uterus dan akhirnya dapat menurunkan rasa nyeri pada saat menstruasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suriani Bahrin, 2022) yaitu, Berdasarkan hasil uji statistics paired t-test diketahui nilai $p=0,001$ sedangkan nilai signifikasi $\alpha<0,005$. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh terapi akupresure terhadap penurunan derajat PMS.

Penulis berasumsi bahwa salah satu dampak dari pijat titik tekanan yang menyesakkan dapat meningkatkan kadar endorphen yang berguna sebagai pembunuh rasa sakit yang dikirim oleh tubuh dalam. Jaringan sensorik akan memberikan peningkatan pada sistem endokrin untuk menghasilkan endorphen sesuai kebutuhan tubuh dan diandalkan untuk mengurangi nyeri selama siklus bulanan. Pijat titik tekan harus dimungkinkan dengan penekanan pada satu titik (tunggal) atau campuran atau campuran yang telah terbukti dapat digunakan untuk mengobati dismenore.

BAB 7

PENUTUP

Buku monograf ini memiliki beberapa tujuan yang dirancang untuk memberikankontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan, khususnya terkait efektifitas pemberian terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 pada remaja putri.

Tujuan penulisan ini meliputi: 1. Menawarkan informasi tentang evektifitas pemberian terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 pada remaja putri, 2. Menjadi suatu alternatif bagi bidan khususnya untuk menurunkan tingkat nyeri *dimenore* primer secara non farmakologi. 3. Supaya lebih menambah kepedulian kepada para remaja terkait kesehatan reproduksi serta *dismenore*, dan cara mengatasinya, 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan terkait efektifitas terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri, 5. Serta sebagai bahan riset selanjutnya mengenai efektifitas terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri. Menjadi referensi belajar dan mengaplikasikan pemahaman ilmu tersebut di lapangan dengan penggunaan terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 pada remaja putri menurunkan tingkat nyeri *dimenore* primer secara non farmakologi.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan dan praktik di bidang kesehatan, kebidanan, serta mempromosikan penggunaan pijat *akupresure* menurunkan tingkat nyeri *dimenore* primer secara non farmakologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyaroh, N. (2021). Kesehatan Reproduksi Remaja. http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210104090/635Kespro_Remaja.pdf diakses tanggal 13 maret 2024.
- Asrinah, Syarifah, J., & Suciyanti. (2021). Menstruasi dan Permasalahannya (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Panasea.
- Achmad Hidayat Asep, (2020). The Effect of Acupressure on the Severity of Nausea, Vomiting, and Retching in Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial. *Complementary Medicine Research*
- Charandabi, Sakineh Mohammad. (2020). The Effect Of Acupressure At The Sanyinjiao Point (SP6) On Primary Dysmenorrhea In Students Resident In Dormitories Of Tabriz. *Complementary Nursing Journal*,16: 119
- Chen, H. M. dan Chen. (2020). Effects acupressure at the sanynjiao point on primary dysmenorrheal. *Journal of Advanced Nursing*, 48 (4),380-387.
- Christina, E.,et al. (2022). Effectiveness of acupressure therapy on menstrual pain perception among adolescent girls with primary dysmenorrheal. *International Journal of Bioassays* 5.10 (2016): 4939-4944
- Clayton, S.G. (2019). Menstruation. *Encyclopædia Britannica*, Inc.
- Desreza et al, (2020). Dysmenorhea. Bandung : Pustaka Panasea

- Devi (2020) Gambaran Tingkat Nyeri Dismenoreia Pada Remaja Putri. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Dwi et al., (2022). Biologi reproduksi. Yogyakarta: Pustaka Riha.
- Dinkes (2023) Kesehatan Reproduksi pada Masa Remaja. Media Sahabat Cendekia
- Efriyanthi, I. S., Suardana, I. W., & Suari, W. (2020). Pengaruh Terapi Akupresure Sanyinjiao Point Terhadap Intensitas Nyeri Dismenore. Pengaruh Terapi Akupresure Sanvinijiao Point Terhadap Intensitas Nyeri Dismenore Primer Pada Mahasiswi Semester VIII Program Studi Ilmu Keperawatan, 3(2), 7-14.
- Fitria, et al. (2020). Clinical review Diagnosis and management of dysmenorrhoea. Jurnal Kesehatan. 12(I)
- Gharloghi, S., Shahnaz, T., Ali, R. A. dan Reza, H. (2021). The effects of acupressure on severity of primary dysmenorrhea". Dovepress. Patient Preference and Adherence 2012;6 137–142.
- Ginsberg, H. J. (2021). Prevalence of dysmenorrhea in female students in a Chinese university: a prospective study. Journal Vol.2, No.4, 311-314 Health doi:10.4236/health.2011.
- Gustina, G. and Safitri, S. (2022) 'Edukasi Hipnosis untuk Menurunkan Nyeri Haid Pada Remaja Putri di Desa Pondok Meja', Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi, 3(4), pp. 21–25. Available at: <https://doi.org/10.47841/saintek.v3i4.249>.
- Hadiyanto, J. S. (2019). Fundamental Of Obstetrics AndGynaecology. Jakarta: Hipokrates,

- Harahap. (2019). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru; 2019.
- Harel. (2022). Manajemen Kesehatan menstruasi. Jakarta: Widina Media Utama
- Hasanah et al. (2020). Terapi Komplementer Pada Kebudanan. Yogyakarta
- Heni (2022) "Acupressure Titik SP6, LI4 dan BL32 Mengurangi Systematic Literature Review," Jurnal MID-Z (Midwivery Zigot) Jurnal Ilmiah Kebidanan, 5(1), pp. 29–40.
- Husnasari, et al . (2020). Dismenore. Jakarta: Gramedia
- Hurlock et al. (2021). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Gramedia
- Ika. (2021). Konsep Menstruasi. Diakses pada tanggal 24 Mei 2024.
[http://mediacostore.com/artikel/249/RemajaPutri dan Siklus Menstruasi.html](http://mediacostore.com/artikel/249/RemajaPutri%20dan%20Siklus%20Menstruasi.html)
- Issabella et al. (2022). Kesehatan Reproduksi. Bandung: Alfabet
- Iswari, & Widya Hartono. (2023). Akupresure Untuk Berbagai Penyakit. Jakarta.
- Judha. (2019). Dismenore Primer dan Faktor Risiko Dismenore Primer pada Remaja. Majority. Vol. 5.
- Julaecha. (2023). Efektifitas Akupresure terhadap dismenore pada remaja putri. Jom Psik, 1, 2.

- Kementrian Kesehatan RI. (2022). Kesehatan Reproduksi pada Masa Remaja. Kementrian Kesehatan RI
- Kemenkes. (2020). Berita Negara Republik Indonesia. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn940-2018.pdf>
- Kusmiran, E. (2020). Kesehatan Reprouksi Remaja dan Wanita (Ist ed.). Jakarta: Salemba Medika.
- Larasati, T. A. (2021). Disminore Primer dan Faktor Risiko Disminore Primer pada Remaja. Sumatera : Universitas Lampung.
- Lestari, A. S. (2019). Access to Personal Hygiene Improves the Quality of Life at Elderly Hostels. International Research Journal of Engineering, IT and Scientific Research, 2(11), 22-28. <https://doi.org/10.21744/irjeis.v2i11.299>
- Manuaba. (2019). Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita. Jakarta: EGC.
- Migwar (2019) Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis (Edisi ke 7, Jilid 1). Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Mufidah, S., Kusumawardani, L.A. and Fadhilah, S. (2022) 'Acupressure Titik SP6, LI4 dan BL32 Mengurangi Nyeri Persalinan Kala I Systematic Literature Review', Jurnal MID-Z (Midwivery Zigot) Jurnal Ilmiah Kebidanan, 5(1), pp. 29-40. Available at: <https://doi.org/10.56013/jurnalmidz.v5i1.1374>.
- Mukhoirotin dan Diah A.F. (2020). Pengaruh Akupresure Pada Titik Sanyinjiao Dan Slow Stroke Back Massage

Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Haid (Dismenorea). Fakultas Ilmu Kesehatan, Unipdu Jombang. MUSWIL IPEMI Jateng, 17 September 2016 .

Nastiti Indriati, S. et al. (2024) Media Gizi Ilmiah Indonesia Hubungan Asupan Zat Besi dan Status Gizi dengan Derajat Dismenore pada Mahasiswi Gizi di UHAMKA
The Correlation Between Iron Intake and Nutritional Status with the Degree of Dysmenorrhea in Nutrition Students at UHAMKA.

Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta

Nurgiwati, E. (2018). Terapi Alternatif & Komplementer Dalam Bidang Keperawatan (1st ed.). Bogor: IN MEDIA.

Nurmiaty, dkk. (2021). Essential Reproduction. Majalah Ilmiah Fakultas Kedokteran Trisakti.

Oka Sukanta and Astuti, R.T. (2020). Efektifitas Akupresure Dan Hipnoterapi Dalam Mengatasi Dismenore Pada Remaja Putri. Jurnal Kesehatan.

Pratiwi, N. (2018). Pintar Kesehatan Wanita. Yogyakarta: Imperium.

Putri, S. A., Yunus, M., & Fanani, E. (2022). Hubungan Antara Nyeri Haid (Dismenore) Terhadap Aktivitas Belajar. Jurnal Kebidanan.

Putri Kusuma et al. (2021). Fisiologi Menstruasi ASASIH VILLASARI STRADA PRESS. Jakarta: Gramedia

Purwanto, B. (2019). Herbal dan Keperawatan Komplementer (1st ed.). Yogyakarta: Nuha Medika.

- Proverawati, A. dan Misaroh, S. (2019). Menarche (menstruasi pertama penuh makna). Yogyakarta : Muha Medika.
- Ridwan, M., & Herlina. (2021). Metode Akupresue untuk Meredakan Nyeri Haid. VIII(1), 51-56.
- Setyawan. (2018). Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia, 9(02), 88-95. <https://doi.org/10.33221/jiki.v902.225>
- Sinaga, E. (2021). Manajemen Kesehatan Menstruasi. Universitas Nasional.
- Sukanta, P. O. (2020). Terapi Pijat Tangan (1st ed.; H. I. Desi S., Ed.). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suriani Bahrn. (2022). Jurnal Obstretika Scientia Efektifitas Akupresur Terhadap Dismenore Pada Remaja. Jakarta: Gramedia
- Tyas, K. J., Apolonia, A.I dan Probo, T. (2021). Pengaruh Terapi Akupresure Titik Sanyinjiao Terhadap Skala Dismenore. Jurnal Kesehatan Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo, vol. 7, 2018, ISSN: 2301-783X.
- Widayati et al,nn. (2022), Jessica Wolff, C.M. and Yauri, I. (2018). Pentingnya Upayaa Penanganan Dismenore Pada Remaja Putri. Juperdo
- Wijayanti, et al. (2021). Akupresure Sanyinjiao Point Mampu Menurunkan Intensitas Nyeri Dismenorhea Primer. Jurnal Smart Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Karya Husada Semarang. Vol.5 No.2des 2021 Issn:2503 – 0388.
- World Health Organization (WHO). (2020). Factsheets Dysmenhorea. Diakses tanggal 26 mei 2024 dari

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Wong CL., Lai KY, & Tse HM. (2020). Effect of SP6 acupressure on Pain and Menstruation Distress in Young Women with Dysmenorrhea. *Complementary Therapies in Clinical Practice*. Volume 16, 64-69.

Yudiyanta, N. K. dan Ratih W. N. (2021). Assessment Nyeri. Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Vol. 42 (3) : 214-215

GLOSARIUM

A

- Adenomiosis : Gangguan yang menyebabkan rahim membesar
Adolesensi : Periode pubertas
Akupresure : Pijatan pada titik-titik tertentu
Alexythimia : Kondisi tidak mampu mengekspresikan diri
Alternatif : Pilihan atau cara lain
Amenore : Gangguan siklus haid
Anterior : Bagian depan
Arterioli : Pembuluh darah kecil
-

C

Corpus luteum: Kelenjar endokrin sementara

D

- Dependen : Tergantung atau terikat
Dismenore : Nyeri perut saat menstruasi
-

E

- Efektif : Sesuatu yang dilakukan berhasil
Ekslusi : Kriteria yang harus dikeluarkan
Endokrin : Jaringan kelenjar yang memproduksi hormon
Endorphin : Hormon pereda rasa nyeri
Epitel : Lapisan yang menutupi permukaan tubuh
Esterogen : Hormon yang berperan pada seksual wanita

F

Fisiologis : Normal

Folikel : Kantung cairan yang berisi oosit

H

Hipofisis : Kelenjar yang berada di bagian dasar otak

Hipomenorea : Pendarahan haid lebih pendek

Hipotalamus : Bagian otak yang mengendalikan hormon

Hormon steroid seks : Pengatur utama karakteristik seksual

M

Menarche : Menstruasi Pertama

Menoragia : Perdarahan menstruasi yang berlebihan

PROFIL PENULIS



Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes. Lahir di Musi Banyuasin Sumatra Selatan, 14 Agustus 1991. Penulis memulai Pendidikan Diploma III (DIII) Kebidanan di Akademi Kebidanan Abdurahman Palembang, lulus tahun 2012, pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan Diploma IV jurusan Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta lulus tahun

2014. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta. Dengan konsentrasi pengajaran Reproduksi, lulus pada tahun 2017. Penulis memiliki kesibukan lain sebagai Dosen Kebidanan di STIKES Adurahman Palembang, mulai bergabung di STIKES Abdurahman Pada tahun 2017 s/d sekarang. Untuk mewujudkan dosen yang profesional penulis mengikuti berbagai pelatihan dan melakukan Tridarma Perguruan Tinggi, Penulis aktif melakukan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, beberapa karya ilmiah telah penulis hasilkan dan dipublikasikan dalam beberapa jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi.

Korespondensi bisa melalui email penulis:

marchatussoleha14@gmail.com

Motto: "Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis."

PROFIL PENULIS



Vika Tri Zelharsandy, M.Keb. Lahir di Palembang Sumatra Selatan, 17 April 1995. Penulis memulai Pendidikan Diploma III (DIII) Kebidanan di STIKES Perdhaki Charitas Palembang, lulus tahun 2015, pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan Diploma IV di jurusan Bidan Pendidik di STIKES Mitra Adiguna Palembang lulus tahun 2018.

Penulis melanjutkan Pendidikan Program Magister Kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2021. Penulis sekarang sebagai Dosen Kebidanan di STIKES Adurahman Palembang, mulai bergabung di STIKES Abdurahman Pada tahun 2021 s/d sekarang. Penulis mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar webinar, pelatihan, workshop dan melakukan Tridarma Perguruan Tinggi, Penulis aktif melakukan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, beberapa karya ilmiah telah penulis hasilkan dan dipublikasikan dalam beberapa jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terakreditasi.

Motto: Mimpi besar, kerja keras dan tak pernah menyerah

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pijat *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri. Banyak remaja mengalami nyeri selama masa menstruasi. Pemilihan metode tradisional seperti *akupresure* mampu mengurangi nyeri *dismenore* yang dilakukan di beberapa titik akupuntur. Untuk mengatasi masalah nyeri *dismenore* tersebut dilakukanlah terapi pijat akupresur pada titik SP6 dan LI 4 yang mana pada titik ini dapat merangsang produksi hormon endorfin.

Terkait dengan produksi *prostaglandin* pada fase luteal, *akupresure* mampu melancarkan peredaran darah, sehingga *prostaglandin* ikut mengalir dalam peredaran darah dan tidak menumpuk pada uterus dan akhirnya dapat menurunkan rasa nyeri pada saat menstruasi.

Buku ini bermanfaat untuk terapi *akupresure* pada titik Sp6 dan LI4 terhadap *dismenore* pada remaja putri. Rata-rata penurunan nyeri *dismenore* pada remaja putri menurun maka hal ini membuktikan bahwa terdapat efektivitas *akupresure* pada titik SP6 dan LI 4 terhadap penurunan *dismenore* pada remaja putri.

Buku ini membahas tentang pijat akupresure pada titik Sp6 dan LI4 terhadap dismenore pada remaja putri. Banyak remaja mengalami nyeri selama masa menstruasi. Pemilihan metode tradisional seperti akupresure mampu mengurangi nyeri dismenore yang dilakukan di beberapa titik akupuntur. Untuk mengatasi masalah nyeri dismenore tersebut dilakukanlah terapi pijat akupresur pada titik SP6 dan LI 4 yang mana pada titik ini dapat merangsang produksi hormon endorphin.

Terkait dengan produksi prostaglandin pada fase luteal, akupresure mampu melancarkan peredaran darah, sehingga prostaglandin ikut mengalir dalam peredaran darah dan tidak menumpuk pada uterus dan akhirnya dapat menurunkan rasa nyeri pada saat menstruasi.

Buku ini bermanfaat untuk terapi akupresure pada titik Sp6 dan LI4 terhadap dismenore pada remaja putri. Rata-rata penurunan nyeri dismenore pada remaja putri menurun maka hal ini membuktikan bahwa terdapat efektifitas akupresure pada titik SP6 dan LI 4 terhadap penurunan dismenore pada remaja putri.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-08-5



9

786347

139085